4. Kennedy P.G.E. Latent Varicella - Zoster virus in human dorsal root ganglia / P.G.E. Kennedy, E. Grinfeld, J.W. Gow // Virology. 1999. Vol. 258, № 2. P. 451-454.

5. Cohrs R.J. Distribution of latent herpes simplex virus type - 1 and, varicella zoster virus DNA in human trigeminal ganglia / R.J. Cohrs, J.J. Laguardia, D. Gil- den // Virus Genes. 2005. Vol. 31, № 2. P. 223-227.

ХУЛОСА

М.Т. Мирзоева, М.С. Исаева

МАСЪАЛАҲОИ КЛИНИКА ВА ҶАРАЁНГИРИИ ТАБХОЛИ ФАРОГИР ДАР СОКИНОНИ ТОҶИКИСТОН

Мақола ба омӯзиши клиника ва ҷараёнгирии табхоли фарогир дар сокинони Тоҷикистон бахшида шудааст. Аз 90 нафари таҳқиқшудагон 57,8%-ро мардҳо ташкил намуданд. Теъдоди беморшудагони сокинони шаҳр назар ба деҳот зиёдтар аст (66,7 ва 33,3). Аз рӯи клиника шакли классикии табхоли фарогир нисбат ба табхоли фарогири мунташир в табхоли чашм бештар мушоҳида шуд.

УДК: 616.7 – 002.729.65 – 061:612.8

Л.А. Николаева, О.И. Касымов

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗНЫХ ТИПОВ ПСОРИАЗА

Кафедра дерматовенерологии (зав. – проф. О.И. Касымов) Таджикского института последипломной подготовки медицинских кадров

Николаева Лилия Александровна – Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров, соискатель, г. Душанбе, пр. Сомони, 59, тел. 918 38 58 99, sashalilya 70 mail@.ru.

Среди 130 обследованных больных псориазом доля 1 типа (наследственно-обусловленного) дерматоза составила 32,3% (42 больных), 2 типа (спорадического) – 67,7% (88 больных). Дебют 1 типа псориаза происходит, в основном, в возрасте 10-20 лет, спорадического – в 20-40 лет; большинство больных 1 типом псориаза находятся в возрасте 16-35 лет, 2 типом – 26-45 лет. Наследственно-обусловленный псориаз имеет более тяжёлое течение и более выраженные иммунологические нарушения.

Ключевые слова: *псориаз, 1 и 2 тип, клиника, иммунологические нарушения.*

L.A. Nikolaeva, O.I. Kasimov

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF DIFFERENT TYPES OF PSORIASIS

Of 130 patients 32.3% (42 patients) had the hereditary tainted psoriasis (1 type) and 67.7% (88 patients) had the sporadic one (2 type). The 1 and 2 types debuted mainly at the age of 10-20 and 20-40 respectively. Most patients were 16-35 (1 type) and 26-45 (2 type) years old. The hereditary tainted psoriasis was more severe and characterized by marked immunological disorders.

Key words: *psoriasis, 1 and 2 type, clinics, immunological disorders.*

Актуальность. Псориаз – это распространённое хроническое воспалительное заболевание со спонтанными ремиссиями и обострениями. Среди стационарных больных дерматологических отделений на долю псориаза приходится от 6,5% до 22,0% случаев, а среди всех больных дерматологического профиля – 5% [1,3]. Псориаз относится к группе заболеваний, не только в значительной степени ограничивающих физические возможности пациента, но и вызывающих весомые изменения в психической сфере. Подобно другим тяжёлым хроническим заболеваниям, он оказывает многогранное влияние на качество жизни человека [2,10]. Эмоциональный, психический фон при псориазе по степени выраженности уступает лишь депрессии и заболеваниям лёгких [12].

В зависимости от семейного анамнеза и дебюта (начала) псориатической болезни большинство исследователей [8,13] выделяют два типа псориаза. Тип I характеризуется как наследственно-обусловленный (более 60% пациентов имеют родственников 1-ой степени, больных псориазом) с ранним дебютом заболевания, чаще между 10-25 годами жизни. К несемейному типу 2 относятся случаи кожного процесса с дебютом после 40 лет и обычно носят спонтанный, непрогнозируемый, т.е. спорадический характер [7,11].

P. Rahman и соавт. в 2000 г. [9] были выявлены достоверные различия по возрасту, семейному анамнезу и воспалительным изменениям в суставах, однако при сравнении наследственно обусловленного и спорадического псориаза P. Stuart и соавт. [13], проанализировав 537 больных с различными проявлениями заболевания, не выявили клинических различий между ними.

В настоящее время установлена важная роль кожи в иммунологическом ответе организма, что позволило определить ведущее место иммунных механизмов и нарушений иммунного гомеостаза в патогенезе псориаза [4,5], однако остаются до конца не изученными иммунологические изменения при различных типах дерматоза, что явилось основанием для проведения данного исследования.

Цель работы: изучение клинико-иммунологических особенностей псориаза у больных разными типами заболевания.

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 130 больных псориазом, которые страдали распространённой вульгарной клинической формой заболевания, протекавшей без осложнений, таких как экссудативная и пустулёзная формы, эритродермия и псориатическая артропатия. Мужчин было 82 (63,1%), женщин – 48 (36,9%). Возраст больных колебался от 16 до 64 лет. Продолжительность заболевания составила от нескольких месяцев до 20 и более лет. Прогрессирующей стадией дерматоза страдали 83 (63,8%) больных, стационарной – 47 (36,2%). Папулёзно-бляшечная клиническая форма псориаза отмечена у 76 (59,2%) пациентов, лентикулярно-нуммулярная – у 54 (40,8%).

Для оценки клинической картины кожного процесса был использован стандартизованный индекс PASI (Psoriasis Area and Severity Index) – интегральный индекс площади псориатических поражений и тяжести процесса. Индекс PASI является основным инструментом для определения тяжести течения псориаза. Он представлен целым числом от 0 (отсутствие болезни) до 72 (самое тяжёлое течение) и отражает площадь поражения с учётом интенсивности проявлений клинических признаков, таких как эритема, интенсивность шелушения и инфильтрации, что принято считать классическими. Минимальный индекс PASI, необходимый для клинических испытаний, равен 18. Это соответствует псориатическому поражению от одной до двух третей поверхности тела.

Иммунологическими исследованиями определяли абсолютное и относительное количество лимфоцитов периферической крови, CD_3 (Т-общие) лимфоциты, субпопуляции (CD_4 – Т-хелперы, CD_8 – Т-супрессоры), CD_{20} (В-лимфоциты), сывороточных иммуноглобулинов А, М, G, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), фагоцитарную активность лейкоцитов (ФГА) и фагоцитарное число (ФЧ). Количественное содержание CD_3, CD_4, CD_8 и CD_{20} лимфоцитов периферической крови определялось методом иммунофлуоресценции «Статус» с использованием набора моноклональных и поликлональных антител. Количественное содержание общих иммуноглобулинов А, М, G в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом,

циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) – методом преципитации полиэтиленгликоля по Ю.А. Гриневичу и А.И. Алферову [6], фагоцитарное число (ФЧ) и фагоцитарную активность нейтрофильных лейкоцитов (ФГА) – по H.A. Park [14].

Контрольную группу составили 30 здоровых лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Возраст и пол больных и контрольной группы были сопоставимы. Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программы Microsoft Excel 2003, определением достоверности различия показателей (p).

Результаты исследования и их обсуждение. Из 130 обследованных больных псориаз 1-го типа (в родословной имеется семейный анамнез по псориазу) установлен у 42 (32,3%) больных, в том числе у 23 мужчин и 19 женщин (54,8% и 45,2% соответственно). В возрасте до 25 лет было 15 (35,7%) больных, до 40 лет – 34 (80,9%). У лиц старше 50 лет псориаз 1 типа наблюдался в единичных случаях (в возрастной группе 51-60 лет – у 7,2% больных, старше 60 лет – у 2,4%). Средний возраст больных в этой группе составил 30,2+1,8 лет.

Псориаз 2 типа (в родословной нет семейного анамнеза по псориазу) отмечен у 88 (67,7%) больных, среди них 59 (67%) мужчин и 29 (33%) женщин. Больных в возрасте до 25 лет было 19 (21,6%) человек, до 40 лет – 51 (57,9%), что соответственно в 1,7 и 1,4 раза меньше, чем в группе больных с 1 типом псориаза. Средний возраст больных спорадическим псориазом составил 36,8+1,7 лет. Таким образом, средний возраст обеих групп достоверно отличался ($p<0,05$).

Первые проявления заболевания (дебют псориаза) у больных с разными типами псориаза начались в разные сроки (табл. 1).

Таблица 1

Возраст начала псориатической болезни

Возраст начала псориаза	I тип псориаза (n=42)		II тип псориаза (n=88)	
	абс	%	абс	%
0-5 лет	3	7,1	0	0
6-10 лет	7	16,7	0	0
11-15 лет	13	30,9	0	0
16-20 лет	10	23,8	9	10,2
21-25 лет	5	11,9	17	19,3
26-30 лет	2	4,8	19	21,6
31-35 лет	1	2,4	16	18,2
36-40 лет	1	2,4	14	15,9
41-45 лет	0	0	8	9,1
46-50 лет	0	0	5	5,7
51-55 лет	0	0	0	0
56-60 лет	0	0	0	0
60 лет	0	0	0	0
Всего	42	100	88	100

Как показывают данные таблицы 1, наследственно-обусловленный псориаз в возрасте до 5 лет дебютировал у 3 (7,1%) больных, до 10 лет – у 10 (23,8%), до 15 лет – у 23 (54,7%), до 20 лет – у 33 (78,5%). Первые признаки болезни у больных с 1 типом псориаза в возрасте старше 40 лет не наблюдались.

Спорадический псориаз дебютировал в возрасте от 16 до 20 лет у 9 (10,2%) пациентов, до 25 лет – в 29,5% случаев (26 пациентов), до 30 лет – в 51,1% (45 пациентов), до 40 лет – в 79,5% (70 больных). У 18 (20,5%) больных наследственно-необусловленным псориазом начало проявлений заболевания

приходится на возраст старше 40 лет. Дебют псориаза 2 типа в возрасте до 15 лет не наблюдался.

Длительность заболевания у пациентов с разными типами псориаза была следующей (табл. 2).

Таблица 2

Продолжительность заболевания у больных разными типами псориаза

Длительность заболевания	I тип псориаза (n=42)		II тип псориаза (n=88)	
	абс	%	абс	%
До 5 лет	5	11,9	23	26,1
6-10 лет	9	21,4	35	39,8
11-20 лет	17	40,5	15	17,1
21-30 лет	6	14,3	9	10,2
31-40 лет	5	11,9	6	6,8
Всего	42	100	88	100

Из данных таблицы 2 видно, что у больных с длительностью болезни до 5 лет среди пациентов наследственно-необусловленным псориазом было в 2,2 раза больше, чем среди пациентов с наследственно-обусловленным (соответственно 26,1% и 11,9%), от 6 до 10 лет – 1,9 раза (соответственно 39,8% и 21,4%). Большинство больных обоими типами псориаза страдали дерматозом до 20 лет (78,3% больных наследственно-обусловленным псориазом и 83% – спорадическим). В среднем продолжительность болезни у больных наследственно-обусловленным псориазом составила 17,6±1,4 лет, а спорадическим – 11,7±1,2 лет, что достоверно меньше ($p<0,01$).

Клиническая картина псориаза у больных обоими типами была схожей, однако поражение ладоней и подошв среди больных с наследственно-обусловленным вариантом заболевания (7,1%) наблюдалось в 1,6 раза чаще, чем среди больных спорадическим псориазом (4,5%). Ногтевые пластинки были поражены у 5 (12%) больных наследственно-обусловленным типом псориаза и у 6 (6,8%) – спорадическим, что в 1,8 раза меньше.

Субъективные ощущения (зуд, жжение, стягивание кожи) у больных обоими типами псориаза определялись с примерно одинаковой частотой.

У всех наблюдавшихся больных псориазом заболевание носило рецидивирующий характер, частота обострений которого отражена в таблице 3.

Таблица 3

Частота рецидивов у больных разными типами псориаза

Частота рецидивов	I тип псориаза (n=42)		II тип псориаза (n=88)	
	абс	%	абс	%
1 раз в год	20	47,6	53	60,2
2-3 раза в год	9	21,4	20	22,6
более 3 раз в год	6	14,3	5	5,7
без ремиссии 1 год	4	9,5	6	6,8
без ремиссии 2-3 года	3	7,1	4	4,5
Всего	42	100	88	100

Как видно из данных таблицы 3, псориатический процесс среди больных спорадическим типом носил более лёгкое течение – у большинства больных (60,8%, n=53) рецидивы заболевания бывали только один раз в год, что в 1,3 раза больше, чем среди больных с наследственно-обусловленным типом (47,6% при n=20). Непрерывное течение псориатической болезни продолжительностью до года и более среди больных наследственно-обусловленным псориазом наблюдалось в 1,5 раза чаще, чем среди больных спорадическим (16,6% и 11,3% соответственно).

Выраженность клинических проявлений псориаза определялась по значениям индекса площади и тяжести псориатических поражений (PASI), что отражено в таблице 4.

Таблица 4

Значение индекса PASI у больных обоими типами псориаза

Значение индекса PASI	1 тип псориаза (n=42)		2 тип псориаза (n=88)	
	абс	%	абс	%
12-14	3	7,1	10	11,4
15-19	10	23,8	31	35,2
20-24	15	35,7	26	29,5
25-29	12	28,6	17	19,3
30-34	2	4,8	4	4,5
всего	42	100	88	100

Как показывают данные таблицы 4, среди больных с наследственно-обусловленным псориазом распространённые, средней степени тяжести и относительно тяжёлые формы заболевания (значение индекса PASI от 20 до 29) наблюдались в 1,3 раза чаще, чем среди больных спорадическим вариантом дерматоза.

Хроническое, рецидивирующее, а у части пациентов непрерывное течение псориатической болезни вынуждает их обращаться за медицинской помощью к врачу-дерматовенерологу. Частота обращаемости больных к врачу была следующей (рис. 1).

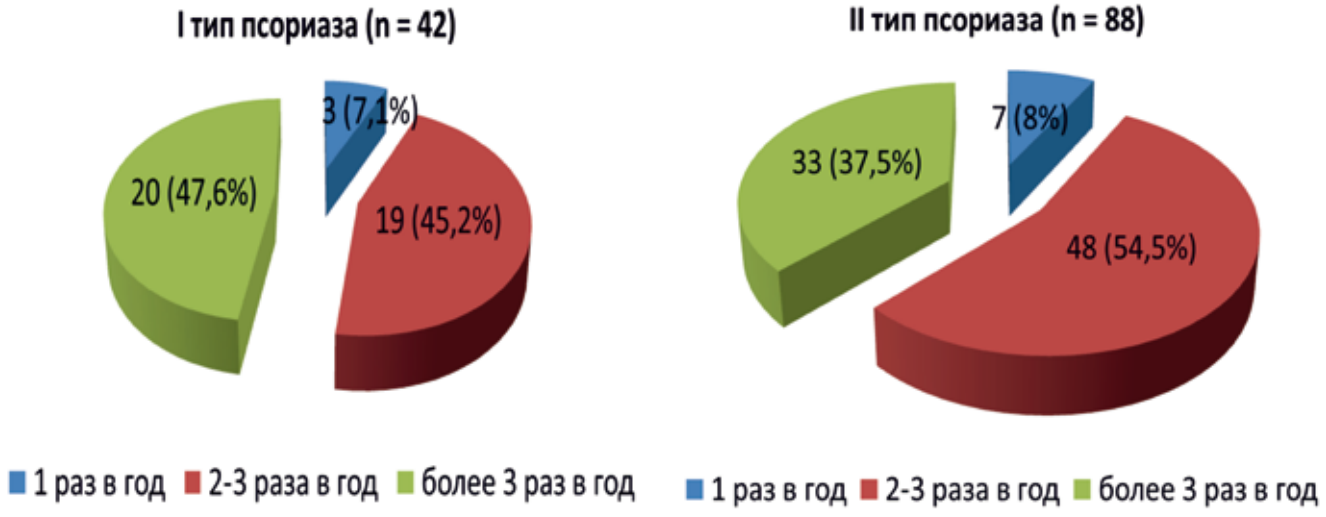


Рис. 1. Частота обращения к врачу больных псориазом

Данные рисунка 1 показывают, что больные наследственно-обусловленным типом псориаза на 27% чаще обращаются к дерматовенерологу: 4 и более раз к врачу обратились 47,6% больных 1 типом псориаза против 37,5% – спорадическим.

Необходимость в получении стационарного лечения больных псориазом отражена на рисунке 2.

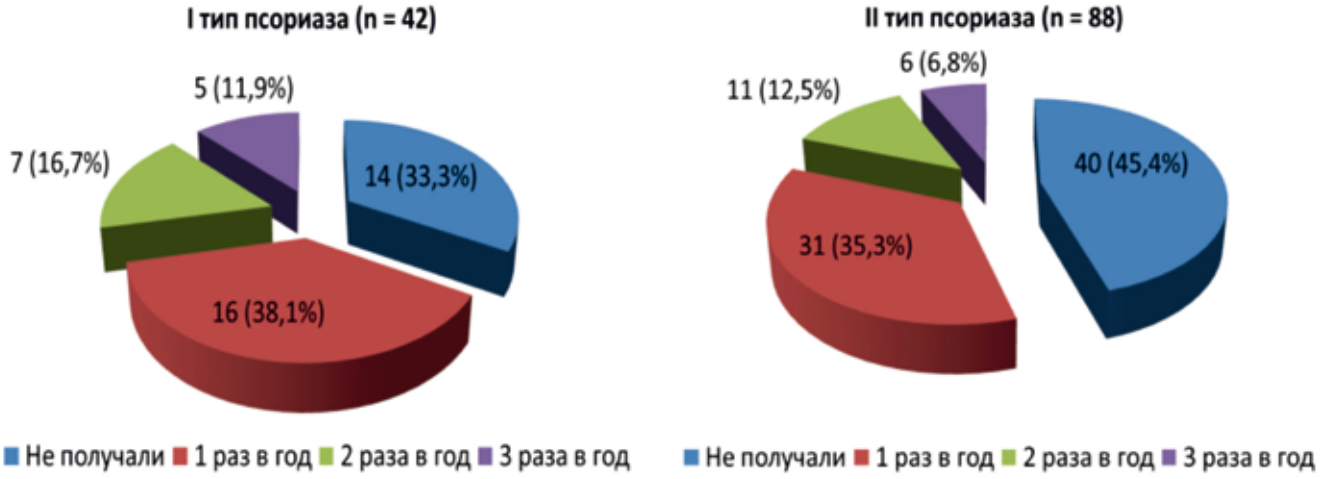


Рис. 2. Потребность в стационарном лечении больных разными типами псориаза

Из данных рисунка 2 видно, что потребность в повторном стационарном лечении (2-3 раза в год) среди больных наследственно-обусловленным псориазом была в 1,5 раза больше, чем у больных спорадическим типом (соответственно 28,6% и 19,3%).

Определение состояния иммунологических показателей у больных с разными типами псориаза дало следующие результаты (табл. 5).

Таблица 5

Состояние иммунологических показателей больных разными типами псориаза

Показатели	Контрольная группа	Типы псориаза	
		1 тип (n=42)	2 тип (n=88)
Лимфоциты, абс.	2177±156	1942±132	2004±127
Лимфоциты, %	32,6±1,9	28,2±1,7	30,1±1,6
CD_3 (Т-лимфоциты), %	68,3±2,9	59,5±2,23(1)	65,7±2,1
CD_4 (Т-хелперы), %	41,8±2,3	32,2±1,93	34,9±1,82
CD_8 (Т-супрессоры), %	25,5±1,9	20,3±1,63	20,7±1,52
CD_4 / CD_8	1,63±0,14	1,77±0,11	1,69±0,10
CD_{20} (В-лимф.), %	14,4±1,1	17,9±1,3	16,8±1,2
IgA, г/л	2,27±0,19	3,41±0,164(1)	2,92±0,151
IgM, г/л	1,94±0,17	2,33±0,131	2,12±0,12
IgG, г/л	14,3±1,3	21,8±1,34(1)	18,3±1,21
ЦИК, г/л	2,14±0,18	3,39±0,164(1)	2,92±0,153
ФАЛ, %	73,7±6,1	55,3±4,52	58,5±4,42
ФЧ	5,7±0,4	4,3±0,51	4,6±0,4

Примечание: достоверность различия к показателям контрольной группы: 1 – $p<0,05$; 2 – $p<0,02$; 3 – $p<0,01$; 4 – $p<0,001$; достоверность различия между данными обеих групп: (1) – $p<0,05$.

Данные этой таблицы показывают, что у больных с 1 типом псориаза (наследственно-обусловленным) наблюдаются выраженные иммунологические нарушения, определяющиеся значительным угнетением активности клеточного отдела иммунитета и увеличением активности – гуморального. Подавление активности клеточного звена иммунитета проявилось снижением количества CD_3-лимфоцитов ($p< 0,01$) и их субпопуляций – CD_4($p<0,01$) и CD_8-лимфоцитов ($p<0,01$). Повышение активности гуморального отдела иммунитета констатировано по резкому увеличению уровня сывороточных IgA (в 1,4 раза) и IgG (в 1,6 раза) и IgM ($p<0,05$), а также ЦИК (в 1,6 раза). Неспецифические факторы защиты были угнетены.

У больных с наследственно-необусловленным псориазом наблюдались аналогичные изменения со стороны показателей обоих звеньев иммунитета, но менее выраженные.

О более глубоких иммунологических нарушениях у больных наследственно-обусловленным псориазом свидетельствует тот факт, что при сравнении состояния иммунологических показателей больных обоими типами дерматоза между собой, у пациентов с 1 типом псориаза отмечается достоверное снижение содержания CD_3-лимфоцитов ($p<0,05$) и увеличение количества сывороточных IgA, IgG и ЦИК (p у всех трёх показателей $<0,05$).

Заключение. Особенностями клинического течения псориаза в жарком климате Таджикистана являются:

- доля наследственно-обусловленного псориаза составляет 32,3%;
- дебют наследственно-обусловленного псориаза, в основном, происходит в возрасте 10-20 лет, спорадического – в 20-40 лет;
- большинство больных наследственно-обусловленным псориазом находятся в возрасте 16-35 лет, спорадическим – 26-45 лет;
- наследственно-обусловленный псориаз имеет более тяжёлое течение, чем спорадический: средней степени тяжести и относительно тяжёлые формы псориаза при нём наблюдаются в 1,3 раза больше; более частые рецидивы и непрерывное безрецидивное течение заболевания определяются в 1,8 раза чаще; больные наследственно-обусловленным псориазом на 27% чаще обращаются за медицинской помощью, на 22% чаще получают стационарное лечение; у больных наследственно-обусловленным псориазом определяются более глубокие иммунологические нарушения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бурханова Н.Р., Фахретдинова Х.С. и др. Медико-географическая характеристика псориаза в Республике Башкортостан. 2-й Всерос. конгр. дерматовенерологов. Тез. науч. раб. Санкт-Петербург. 2007. С. 6.

2. Довжанский С.И. Качество жизни – показатель состояния больных хроническими дерматозами / С.И. Довжанский // Вестник дерматол. и венерол. 2001. № 3. С. 12-13.

3. Кунгуров Н.В. Псориатическая болезнь [Текст] / Н.В. Кунгуров, Н.Н. Филимонкова И.А. Тузанкина. Издательство Уральского государственного университета. Екатеринбург. 2001. 200 с.

4. Мордовцев В.Н. Современные концепции по патогенезу псориаза // Вестн. дерматол. и венерол. 1999. № 3. С. 28-33.

5. Хайрутдинов В.Р., Самцов А.В. Современные представления об иммунных механизмах развития псориаза (обзор литературы). Вестн дерматол. и венерол. 2007. № 1. С. 3-7.

6. Гриневич Ю.А., Алферов А.И. Способ определения циркулирующих иммунных комплексов. Лабораторное дело. 1981. № 8. С. 493-496.

7. The major psoriasis susceptibility locus PSORSI is not a risk factor for late-onset psoriasis [Text] / M. Allen, H. Ameen, C. Veal, J. Evans // J. Invest Dermatol. 2005. Vol. 124. № 1. P. 103-106.

8. Barker J.N. The pathophysiology of psoriasis [Text] / J.N. Barker // Lancet. 1991. Vol. 338. P. 227-230.

9. Rahman P., Ngyen E., Cheung C. et al. Psoriasis and Psoriasis arthritis // J. Reanimatol. 2000. Vol. 28. P. 41-44.

10. Fitzpatrik T. Dermatology in general medicine. Mc Graw Hill Medical. 2003. P. 511.

11. Ortonne N. Psoriasis: Pathogenesis [Text] / N. Ortonne, J.P. Ortonne // Presse Med. 1999. Vol. 28. № 23. P. 1259-1265.

12. Rapp K. Cancer risk associated with the treatment of psoriasis [Text] / K. Rapp, P. Beauparland // JEADV.1999.Vol. 11 (Suppl.2). P. 291-298.

13. Stuart P. et al. 2002 analysis of phenotypic variation in psoriasis as a function of age at onset and family history [Text] / P. Stuart, F. Malick, R.P. Nair, T. Hensder // Arch Dermatol Res. 2002. Vol. 294. № 5. P. 207-213.

ХУЛОСА

Л.А. Николаева, О.И. Қосимов

ХУСУСИЯТҲОИ КЛИНИКӢ-МАСУНИЯТИИ НАВЪҲОИ ГУНОГУНИ ШУКУФАИ ХУШКИ ФАЛСӢ

Дар байни 130 беморони муоинашудаи шукуфаи фалсӣ дошта навъи 1 – ум (хусусияти ирсӣ дошта) 32,3% (42), навъи дуюм (спорадикӣ - гоҳ гоҳ вохӯранда) – 67,7% (88) – ро ташкил дод. Навъи якум дар синни 10-20 солагӣ, навъи дуюм бошад дар синни 20-40 солагӣ во мехурад. Сину соли беморони навъи якум 16-35 сола, навъи дуюм бошад – 26-45 соларо ташкил дод. Шукуфаи фалсии хусусияти ирсӣ дошта нисбатан вазнин ва бо халалёбиҳои иммунологӣ мегузарад.

УДК 613.84; 616.153.915

Дж.Х. Нозиров, А. Ахмедов, З.Я. Рахимов, К.Ф. Зайдуллоев

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА СРЕДИ НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ ТАДЖИКИСТАНА

Кафедра общественного здоровья, экономики, управления (менеджмента) здравоохранением с курсом медицинской статистики (зав. – проф. А. Ахмедов), кафедра кардиологии с курсом клинической фармакологии (зав. – доц. З.Я. Рахимов) ТИППМК

Нозиров Джамшед Ходжиевич – кандидат медицинских наук, соискатель-докторант кафедры общественного здоровья, экономики, управления (менеджмента) здравоохранением с курсом медицинской статистики ТИППМК, центральная городская больница г. Вахдат, менеджер госпитальной службы. Тел: 8313622747 (918-56-26-00), почтовый адрес: 735400, г. Вахдат, ул. Тугдона 39, эл. адрес: doctor-vahdat@mail.ru

Осуществлены повторные клинико-лабораторные обследования неорганизованной части сельской популяции в возрасте 15-59 лет, которые включили 5000 человек при первом (2003) и 16500 – при повторном (2012) исследовании. Среди них состояние липидного обмена проанализировано у 400 (8%) обследованных: у 239 мужчин и 161 женщины при первом исследовании и у 1543 (9,3%): у 683 мужчин и 860 женщин – при повторном. За